

31. DIAFRAMMA PRATICO - 3 TECNICHE

DURATA : 16:09

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video presenta due tecniche di rilascio del diaframma, essenziali per migliorare la funzione respiratoria e lo stato generale dei pazienti, in particolare dei bambini. La prima tecnica si concentra sulla giunzione esofagea e diaframmatica, sfruttando movimenti a spirale e l'ascolto tissutale per rilasciare la pressione a livello del diaframma. Il protocollo pratico dettagliato include fasi di valutazione della nuca, di rilascio e di mobilizzazione, volte a restituire libertà di movimento. La seconda tecnica mira alla retrocavità degli omenti e alle inserzioni esofagee, sottolineando l'importanza dell'interazione tra le coste e il diaframma. Questi approcci, radicati nella pratica biodinamica, mirano al benessere globale del paziente.

DIAFRAMMA PRATICO - 3 TECNICHE

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE DIAFRAMMATICHE

Esploreremo due tecniche principali. La prima è un approccio **meccanico** per liberare lo spazio diaframmatico. La seconda è un approccio **globale** al diaframma, particolarmente efficace nei bambini e nei neonati, per ripristinare un'**espansione ottimale**. Questa tecnica rientra in una pratica di tipo **biodinamico**.

TECNICA 1: LIBERAZIONE DELLA GIUNZIONE ESOFAGEA E DIAFRAMMATICA

Lavoreremo specificamente sull'**incrocio** tra l'esofago e il diaframma. Questa regione è ricca di **reti nervose**, in particolare con il tronco del **nervo vago**. L'obiettivo è liberare delicatamente questa zona, il che avrà l'effetto di scaricare tutta l'area vagale circostante.

ANATOMIA CHIAVE

- Osserveremo la porzione diaframmatica destra e sinistra.
- La **pleura** è anch'essa presente qui.
- C'è un residuo anatomico, anticamente una vena, chiamato la **vena di Treitz e Lehmer**.
- Un piccolo muscolo si inserisce sul diaframma e sul peritoneo, formando lo spazio **peri-esofageo**. Questo spazio ha una funzione di adattabilità e riequilibrio rispetto alla giunzione

diaframmatica.

- Questa struttura si prolunga con il **muscolo di Treitz**, che è il legamento sospenditore del duodeno.

IL MOVIMENTO SPIRALIFORME DEL CORPO

Il corpo è spesso organizzato in **spirali**, un movimento potente che si ritrova ovunque. L'embrione stesso si sviluppa secondo movimenti spiraliformi. Utilizziamo le spirali in energetica per mirare a punti precisi. Qui, applicheremo questo principio di movimento spiraliforme.

PROTOCOLLO PRATICO

1. **Localizzazione:** Posizionatevi a livello della giunzione, dove potete avere accesso alla parte più alta dello stomaco.

2. Test Preliminare del Collo:

- Ruotate la testa a sinistra e sentite la sensazione.
- Tornate al centro, poi ruotate la testa a destra.
- Tornate al centro, poi ruotate la testa a sinistra di nuovo. Notate se la rotazione è limitata. Molto spesso, questa zona diaframmatica impedisce una buona rotazione del collo.

3. Posizionamento e Rilascio:

- Posizionatevi e lasciate che la persona cada all'indietro verso di voi.
- Chiedetele di rilassarsi completamente. Mantenete la persona.
- Mantenete un punto di appoggio con il pollice.

4. Discesa e Ascolto Tissutale:

- Iniziate a scendere delicatamente, in profondità. Cercate i tessuti.
- Ascoltate i tessuti. Osservate la respirazione della persona. All'espiazione, scendete e incontrate un leggero blocco, una certa densità.

5. Stabilizzazione e Mobilizzazione Progressiva:

- Posizionatevi delicatamente, prendendo un buon punto di appoggio posteriore, ben dritti, per essere stabili.
- Verificate che la persona non senta dolore.
- Scendete ancora, lasciando un piccolo margine a causa dei vestiti.
- Chiedete alla persona di raddrizzarsi molto delicatamente. Potete sentire il "hop" risalire con voi.
- Ripetete il movimento: risalita dolce, poi rilascio. Guadagnate terreno.
- A volte, sentite un "freno" e cercate un po' più in là, risalendo e ridiscendendo.

6. Presa Posteriore e Sensazione:

- Prendete poi la parte posteriore tra le due mani.
- Chiedete alla persona di rilassarsi completamente. Verificate l'assenza di dolore eccessivo.
- Una sensazione può farsi sentire, poi "si apre a livello della vescica".

7. Verifica Post-Tecnica:

- Cercate un appoggio posteriore e tornate.
- Chiedete alla persona di girare la testa a sinistra di nuovo per verificare la mobilità.

TECNICA 2: LIBERAZIONE DELLA BORSA OMENTALE E DELLO STOMACO

Questa tecnica si concentra sulla borsa omentale e sulle inserzioni esofagee. Non dimenticate l'importanza delle **coste** in relazione al diaframma, dove c'è una concentrazione importante.

PROTOCOLLO PRATICO

1. **Localizzazione:** Posizionatevi dove si forma il "buco".
2. **Posizionamento della Mano:** Posizionate la mano piatta verso la giunzione, a livello delle 7a, 8a, 9a costa.
3. **Scivolamento e Rilascio:** Fate scivolare la mano sotto e appoggiatela piatta. Poi, venite con l'altra mano.
4. **Braccio di Leva:** Rilasciate e create un piccolo braccio di leva. Questa zona è un importante crocevia di tensioni.
5. **Effetti:**
 - Questo rilascerà tutta la giunzione stomaco-cardias.
 - Questo rilasserà la zona muscolare di Treitz e le strutture associate.
 - Questo agisce su questa relazione vitale.

SENSAZIONE GLOBALE E TASCA RETROGASTRICA

- Concentratevi su una sensazione più globale. Toccate tutto il corpo.
- La **tasca retrogastrica** è molto importante da mobilizzare. Le ulcere sono spesso posteriori e questa tasca ha bisogno di mobilità per un buon peristaltismo e una buona funzione. Deve essere libera.
- Se non è ben libera, non è liberata rispetto al diaframma.

COLLEGAMENTI ANATOMICI ESSENZIALI

- L'esofago e lo stomaco sono i primi organi in relazione con la base del cranio.

- Hanno una relazione con il **mesogastrio posteriore**, il corno e i bronchi principali sinistri. Potete sentire il calore salire, poi scendere.

APPROCCIO BIODINAMICO E SVILUPPO EMBRIONALE

Ora esploro un altro livello: la forza dello **sviluppo embrionale**, il sostegno, la potenza. Osservo la respirazione e percepisco un lavoro fasciale che mira a dare più spazio tra il diaframma e la zona polmonare posteriore.

IL PIANO PERITONEALE

- Sul piano peritoneale, l'**angolo colico sinistro** è il primo punto fisso dello sviluppo globale del peritoneo. È il primo punto di appoggio.
- Concentratevi su questo punto di appoggio, poi sul punto di mobilità.
- Il punto più mobile è il **cieco**, l'ultimo a mettersi in posizione. Valutate come si presenta.
- Tra le vostre due mani, avete tutto l'asse di rotazione del colon. Il diaframma lavora su queste strutture.
- In questo spazio, avete tutti i legamenti, come il **legamento falciforme**.

SCELTA TERAPEUTICA

Il praticante può scegliere su cosa lavorare, ma spesso il corpo del paziente guida questa scelta.

- Ad esempio, una tensione sul legamento falciforme, o sul suo foglietto.
- A volte, c'è l'espressione di una "gentile rabbia", come se mancasse un punto di appoggio posteriore, o ci fosse bisogno di una liberazione qui.
- Questo lavoro si svolge in sincronia con la tenda del cervelletto, la falce cerebrale, a livello della **crista galli**. Si lavorerà sul seno.

ESPRESSIONE DELLA RABBIA IN BIODINAMICA

La rabbia può esprimersi come un'incapacità in un dato momento di esprimersi. Questo può risalire a molto tempo fa, legato a ciò che non si è potuto dire. In biodinamica, afferro il protocollo mettendomi sulla globalità. Lascio la respirazione toracica ed entro nello spazio, lasciandolo aperto. Il corpo mi guida quindi verso punti di appoggio. Possono apparire dei "flash", indicando una tensione.

LA CHIAVE DELL'APPROCCIO BIODINAMICO (INIZIATICO)

- Immergetevi nell'acqua (metaforicamente).
- Ascoltate il movimento.
- Sentite il movimento.
- Cercate la **bilancia** (il punto di equilibrio).
- Una volta trovato il punto di bilancia, ascoltate il silenzio dietro.

Quando le cellule "rispondono" e si aprono alla ricezione, è un **"accensione" cellulare**.

PRECAUZIONI E POSIZIONAMENTO DELLE MANI

Quando si approccia il diaframma, si tratta di dare spazio al diaframma.

ERRORI DA EVITARE

- **Premere sulla testa:** Bisogna avere una sensazione equa tra le mani. Un errore grave è premere sulla testa della persona, il che è molto sgradevole a lungo andare.
- **Postura scorretta:** Avere un buon appoggio sui gomiti.

CONSIGLI DI POSIZIONAMENTO

Immaginate di mangiare aglio e di prendere il giusto spazio. È cruciale trovare il giusto spazio.

GUIDA MEDITATIVA E STATO DEL TERAPISTA

In questa pratica, vi guiderò in uno stato **meditativo**.

- Posizionatevi esattamente nella posizione corretta.
- Come ricevente, cercate di definire la vostra percezione della posizione.

SENSAZIONE DEL TOCCO

Il tocco è molto leggero, con molto calore. È globale, si ha l'impressione che si estenda fino ai piedi. Allo stesso tempo, c'è questa sensazione che io colgo il **"campo micro-cristallino"**: tutte queste cellule, questa piccola rete cellulare con i loro recettori. È un campo enorme.

IL CAMPO DEL GLICOCALICE

Il più grande luogo di concentrazione di informazioni di un campo di **glicocalice** si trova a livello del **secondo duodeno** – la parte più informata dell'intestino. Questo campo è presente ovunque sul corpo, come un campo globale che comprende tutto. Questo permette di stabilire un contatto profondo.